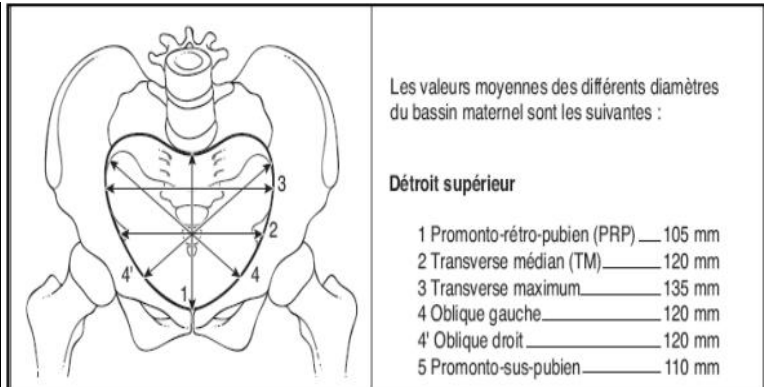


vertébral réunissant la dernière vertèbre lombaire et le sacrum.

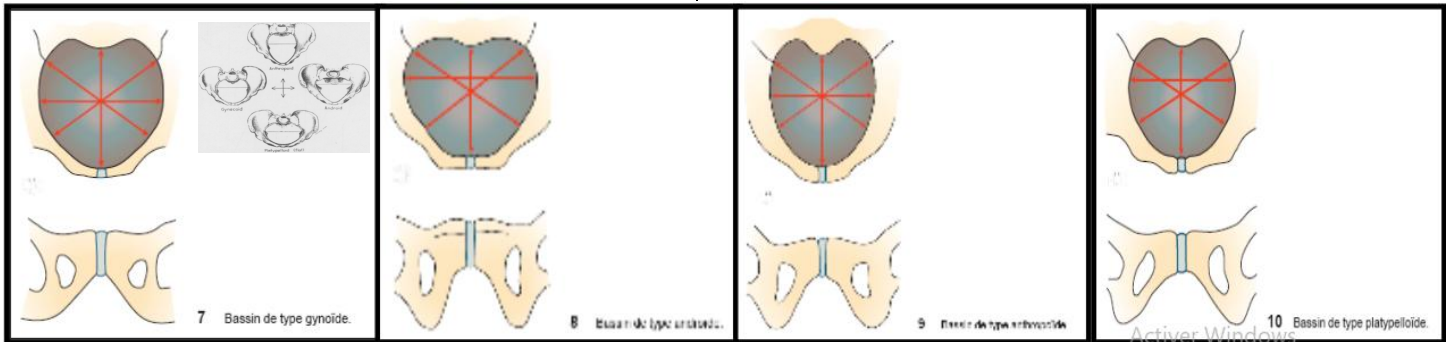
- ✓ **En avant** : par le bord sup de la symphyse pubienne.
- ✓ **Latéralement** : par les lignes innommées.
- ✓ **En arrière** : par le promontoire.

*La saillie du promontoire lui donne une forme en cœur de carte à jouer.

*Pour déterminer le pc d'un accouchement par VB, on utilise « l'indice du DS » ou « Indice de Magnin ». Il est le plus utilisé en France, il est égal à la somme du diamètre promonto-rétropubien et du diamètre transverse médian : **IM = PRP + TM (normal >23cm)**



*Les diverses formes du DS sont :



*Même si classiquement le bassin féminin est de forme gynécoïde, la forme du détroit supérieur peut être très variable et il est possible de décrire d'autres morphotypes :

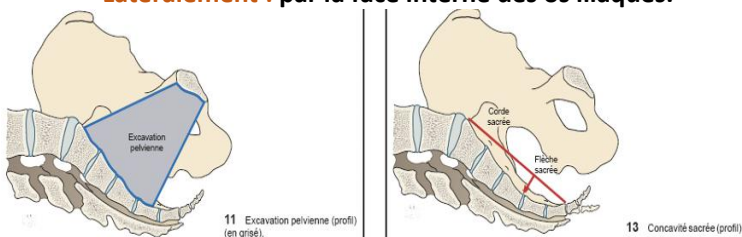
- Le bassin androïde ou triangulaire
- Le bassin anthropoïde ou oval
- Le bassin platypelloïde ou plat

1.2-Détroit moyen : Descente et rotation

*Il a la forme du **segment de tore** (cylindre incurvé) enroulé autour de la symphyse pubienne.

*Il est limité :

- **En avant** : par la face postérieure de la symphyse.
- **En arrière** : par la face antérieure du sacrum.
- **Latéralement** : par la face interne des os iliaques.



*Au niveau du DM les axes sont de :

Au niveau du détroit moyen :

- oblique : 110 mm ;
- antéropostérieur : 120 mm ;
- transverse bischiatique : 100 mm.

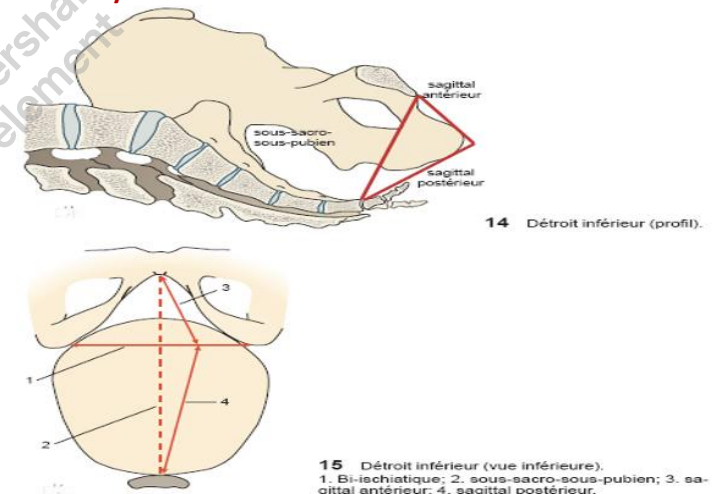
1.3-Détroit inférieur : Dégagement

*C'est l'**orifice inférieur** du canal pelvien, défini comme l'espace compris entre les plans du DM et les plans du DI.

*Ses limites:

- **La face supérieure** : est représentée par le plan du DM.
- **La face antérieure** : oblique en bas et en arrière, joint le bord inférieur du **pubis** aux **ischions** en suivant les branches ischio-pubiennes.

- **La face postérieure** : oblique en haut et en arrière est déterminée par les **2 ischions** et la pointe du **coccyx**.

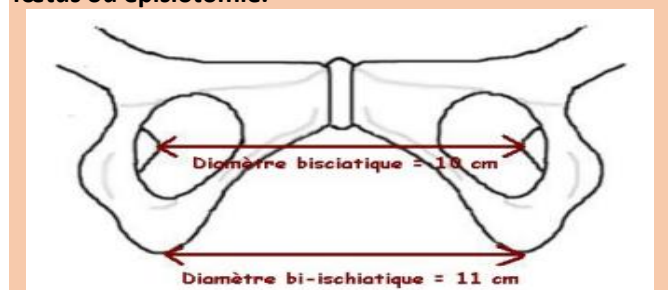


*Les diamètres du DI :

Les diamètres du détroit inférieur :

- sous-coccy-sous-pubien : 85 mm modifiée à 115 mm (par la rétroimpulsion du coccyx) ;
- sous-sacro-sous-pubien : 115 mm ;
- bi-ischiatique : 110 mm.

*Le détroit inférieur ne pose pas de problème lors de l'accouchement, worst cases : fracture du coccyx par le fœtus ou épisiotomie.



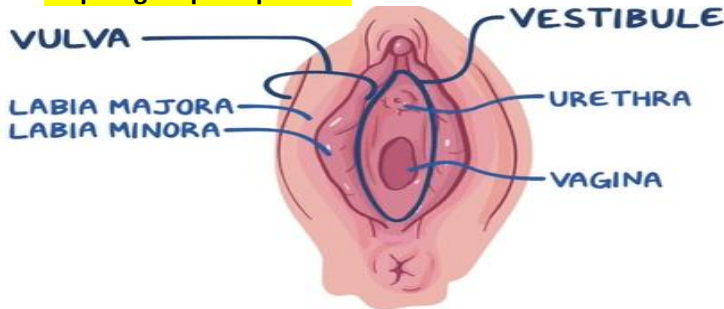
1.4-Le bassin osseux : côté pratique :

Bassins	PRP (mm)	TM (mm)	Indice de Magnin	Biscliatique (mm)	Bi-ischiatique (mm)
« normaux »	> 105	> 115	> 23	> 95	> 90
« limites »	< 105 > 85	< 115 > 95	< 23 > 20	< 95 > 80	< 90 > 80
« chirurgicaux »	< 85	< 95	< 20	< 80	< 80

PRP : promontorétopubien; TM : transverse médian.

2-Bassin mou :

*Le bassin mou est constitué du **vagin** et du **diaphragme pelvi-périnéal**.



*Le **diaphragme pelvi-périnéale** : est le hamac musculotendineux qui comprend :

- **Un plan superficiel** : muscles du périnée superficiel

*Le plan superficiel du périnée comprend quatre muscles et l'aponévrose périnéale superficielle dans sa partie antérieure et le sphincter externe de l'anus dans la partie postérieure.

• Au niveau du périnée antérieur ou uro-génital, les

muscles sont :

- le muscle ischio-caverneux,
- le muscle bulbo-spongieux,
- le muscle transverse superficiel,
- le muscle constricteur de la vulve.

• Au niveau du périnée postérieur ou anal, on retrouve :

- Le sphincter externe de l'anus

- **Un plan profond** : fibres du **releveur de l'anus**, **muscles ischiococcygiens** et **grand ligament sacrosiatique**

→ Ces éléments se laissent distendre et constituent un **tube ouvert en avant et en bas**, ayant la forme d'une **boutonnière médiane antéropostérieure**.

*Le plan profond est formé de deux muscles pairs qui délimitent la partie basse de l'excavation pelvienne :

- Le muscle élévateur de l'anus qui est constitué de plusieurs faisceaux,
- Le muscle coccygien.

*Ensemble, ils constituent le **diaphragme pelvien** qui sépare la cavité pelvienne du périnée.

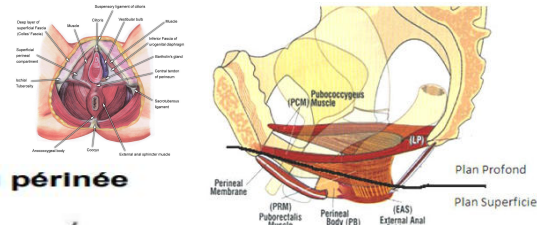


Figure 4 : Les muscles superficiels du périnée

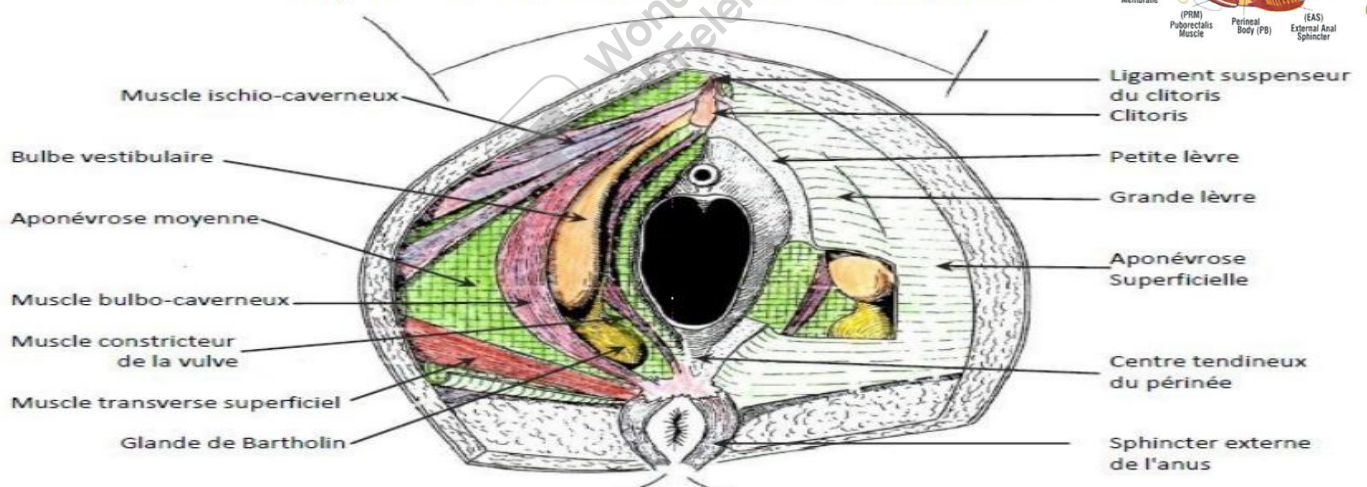
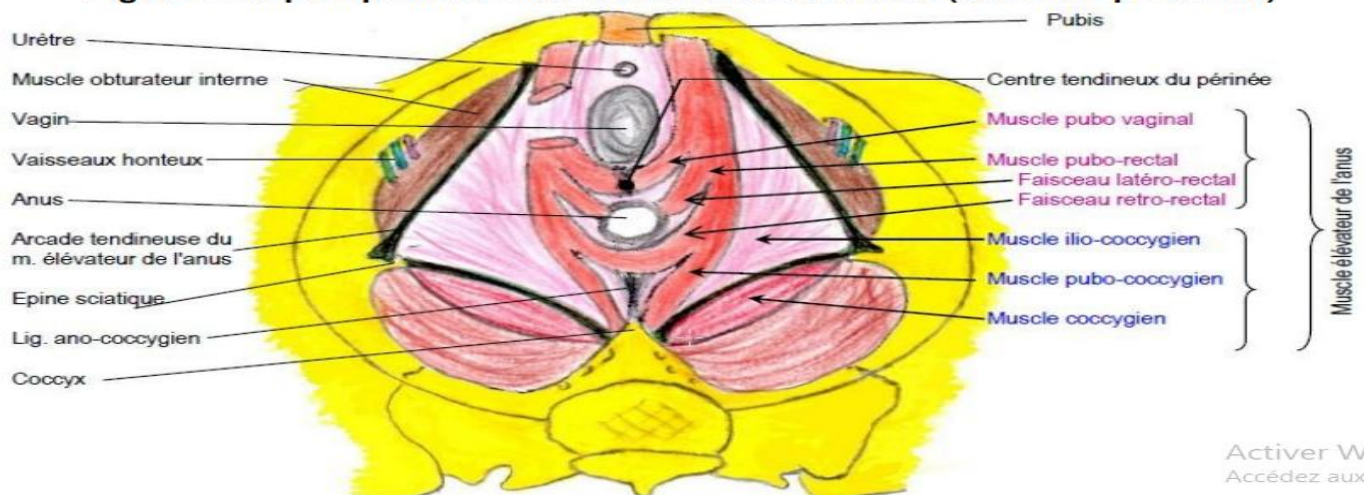


Figure 7 : le plan profond : Muscle élévateur de l'anus (vue endo pelvienne)



3-Mobile fœtal :

*Après avoir examiné le bassin il faut voir si c'est un bébé normal → HU = **32 cm** à terme (on confirme par écho).

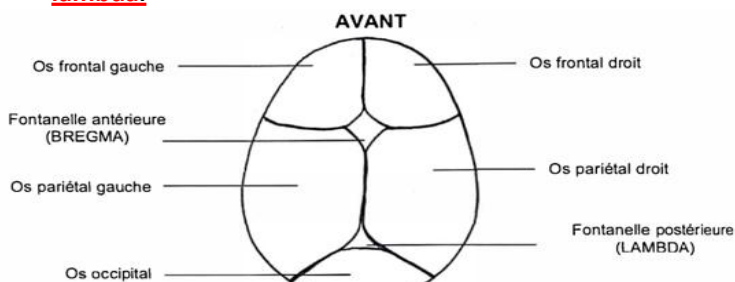
*On appelle **présentation** la partie du fœtus qui se présente en 1^{er} dans l'aire du bassin.

3.1-Tête fœtale :

*Elle a une forme **ovoïde** dont la **petite extrémité** correspond au **menton** et la **grosse** à l'**occiput**.

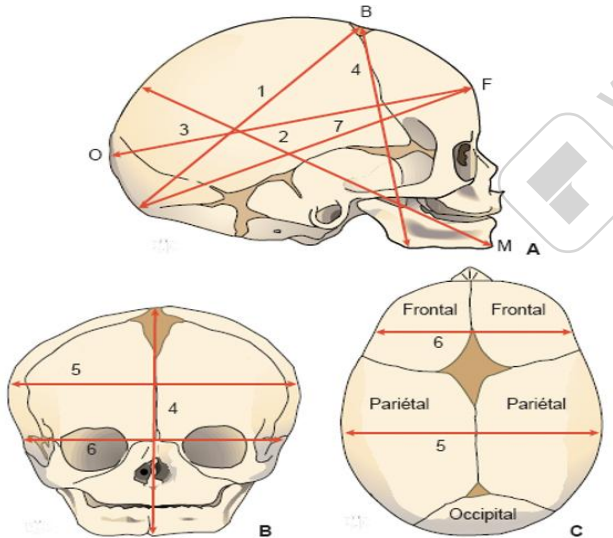
*On décrit sur :

- La **ligne médiane** : la suture **longitudinale**,
- Sur laquelle : il y a **2** autres sutures transversales, l'une **antérieure** et l'autre **postérieure**,
- Au croisement de la **SL** par ces 2 autres il y a **2 fontanelles**, l'une **antérieure** ou **bregmatique** ou **bregma**, et l'autre **postérieure** ou **lambdoïde** ou **lambda**.



ARRIERE

*Les dimensions de la tête sont :



16 Dimensions de la tête fœtale.
1. Sous-occipito-bregmatique 95 mm ; 2. sincipitomentonnier 135 mm ; 3. occipito-frontal 128 mm ; 4. sous-mento-bregmatique 95 mm ; 5. bipariétal 95 mm ; 6. bitemporal 80 mm ; 7. sous-occipito-frontal 110 mm ; O : occipital ; B : bregma ; F : frontal ; M : menton.

- Dimensions de la tête fœtale
- bipariétal : 95 mm ;
- occipitofrontal : 128 mm ;
- sous-occipitofrontal : 110 mm ;
- sous-occipitobregmatique : 95 mm ;
- sus-occipitomentonnier : 135 mm ;
- sincipitomentonnier : 135 mm ;
- sous-mentobregmatique : 95 mm ;
- bitemporal : 80 mm ;

3.2-Corps fœtal :

*Les autres dimensions fœtales à connaître sont :

- **Biacromial** : 12cm réduits à 9,5cm par tassement.
- **Bitrochantérien** : 9cm
- **Bi-iliaque** : 8cm
- **Sacropubien** : 7,5 cm

- **Sternodorsal** : 9,5 cm

- **Sacro-prétilial** : 12cm réduits à 9cm par tassement.

3.3-Les présentations :

QE!!



Définition des présentations.

La **présentation** est la partie du fœtus qui prend contact avec le DS, s'y engage (ou tend à s'y engager) et évolue dans l'excavation pelvienne selon un mécanisme qui lui est propre jusqu'à l'expulsion du fœtus.

Présentations	Repères	Diamètre fœtal se présentant au DS
Longitudinales		
Tête		
- Sommet	Occiput (lambda)	Bipariétal
- Face	Menton	Sous-mentobregmatique
- Front	Nez	Sincipitomentonnier
- Bregma	Bregma	Occipitofrontal
Siège		
- Complet	Sacrum	Sacroprétilial
- Décomplet	Sacrum	Bitrochantérien
- Semi-décomplet	Sacrum	Sacroprétilial
Transversale		
Épaule	Acromion	-

On appelle position l'orientation à gauche ou à droite (par rapport à la mère) du dos du fœtus.

Les **variétés de position** sont déterminées par la situation du repère de la présentation par rapport au bassin maternel (pour le sommet dont le repère est l'occiput, figure 18.4) : OP (occipitopubienne), OIGA (occipito-iliaque gauche antérieure), OIGT (occipito-iliaque gauche transverse), OIGP (occipito-iliaque gauche postérieure), OS (occipitosacrée), OIDP (occipito-iliaque droite postérieure), OIDT (occipito-iliaque droite transverse) et OIDA (occipito-iliaque droite antérieure).

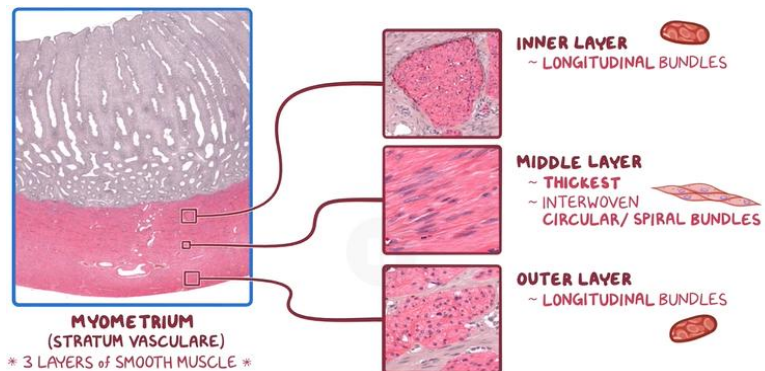
Bassin normal + bébé normal → Voie basse.

4-Phénomènes dynamiques : utérus gravide :

* L'utérus gravide comprend trois parties : le corps, le segment inférieur et le col.

* L'utérus est constitué de trois tuniques :

- La **séreuse** : se clive facilement au niveau du segment inférieur ;
- La **muqueuse** : transformée en caduque lors de la grossesse ;
- La **muscleuse** ou **myomètre** : les faisceaux de fibres musculaires lisses sont disposés en deux assises circulaires externe et interne de part et d'autre de la couche plexiforme dont les faisceaux enserrant de nombreux vaisseaux



* Les fibres musculaires sont groupées en **faisceaux** de **100 fibres** environ.

* Le faisceau constitue l'unité physiologique élémentaire de l'utérus. En fin de grossesse, la fibre musculaire est une cellule en **fuseau** de 250 µm de long sur 15 µm de large, contenant des protéines contractiles, type actomyosine, et un potentiel énergétique représenté par l'adénosine triphosphate (ATP) qui existe sous forme libre.

5-Mécanisme de déclenchement spontané du travail :

*Le mécanisme exact est encore mal connu, mais on note un rôle fondamental des **prostaglandines**.

6-Contractions utérines :

*C'est la force motrice qui permet au cours de l'accouchement la dilatation du col utérin et la progression du mobile fœtal dans la filière génitale.

*Elles résultent d'un glissement des filaments d'actine et de myosine, les uns par rapport aux autres.

* Les contractions utérines sont:

- Involontaires.
- Intermittentes,
- Totales, intéressant tout l'utérus.
- Douloureuses à partir d'un certain seuil d'intensité.
- La durée des périodes de repos oscille entre 1 et 3 minutes

* Leur rôle est :

- ✓ Poussée du fœtus vers la région segmento-cervicale
- ✓ L'effacement et la dilatation du col utérin
- ✓ Ampliation de la poche des eaux et du segment inférieur

III-Examen clinique :

1-Objectif : Eliminer l'urgence++, Evaluer le pc

*Tout d'abord, il faut déterminer la situation d'urgence :

- Hémorragie
- Convulsions
- Procidence

*En cas d'urgence, il faut réaliser les gestes suivants :

- Prescrire des examens complémentaires :
 - ✓ **Systématiques** : Groupage, Rh, NFS, plq, hémostase, RCF
 - ✓ **Non systématiques** : Echo (présentation, biométrie, placenta), radiologiques (radiopelvimétrie)
- Faire le dc de début de travail
- Proposer une conduite : VB, césarienne, épreuve du travail, épreuve utérine, transfert..

*En dehors de l'urgence ; il faut :

- ✓ Faire connaissance avec la patiente et l'interroger sur : le MDC, les ATCDs, l'histoire de la grossesse actuelle
- ✓ Examiner la patiente (Pouls, TA, T°, signes cardioVx, respiratoires et neurologiques), et l'utérus avec le bassin (HU, présentation, dilatation du col, engagement)
- ✓ Examiner le fœtus et les annexes : nombre, vitalité, trophicité, présentation, topographie du placenta, état des membranes..

*L'interrogatoire nous permet d'évaluer le pc de l'accouchement :

Renseignements concernant la patiente :

- âge, ethnie, situation familiale, lieu de résidence;
- profession (chômage éventuel), transport;
- mode de logement, conditions socio-économiques.

Antécédents familiaux :

- maladies héréditaires (hémophilie, etc.);
- malformations;
- hypertension artérielle;
- diabète, obésité, phlébites;
- cancers gynécologiques.

Antécédents médicaux :

- hypertension artérielle, diabète, phlébite;
- infections urinaires;
- allergies, autres affections (traitement, séquelles, etc.).

Antécédents chirurgicaux :

- chirurgie traumatologique (bassin);
- chirurgie osseuse (rachis);
- chirurgie abdominale (appendicite);
- chirurgie gynécologique.

Antécédents gynécologiques :

- puberté, régularité des cycles, stérilité (étiologie, traitement);
- contraception et sa tolérance;
- date du dernier frottis cervico-vaginal.

Antécédents obstétricaux :

- nombre de fausses couches, IVG;
- nombre et modalités des accouchements.

*Quand on parle de l'examen physique, on parle d'un examen complet de l'utérus gravide, de périnée, du col utérin et d'un TV.

2-Inspection :

*La mesure de la taille :

- Les femmes de plus de 1m60 n'ont généralement pas de rétrécissement pelvien.
- Les femmes dont la taille est inférieure à 1m50 font partie d'un groupe à risque (1m52 pour Parson) ;
- *L'aspect morphologique : recherche d'une scoliose, d'une gibbosité en regardant la femme de face, de profil et de dos ;
- *La recherche d'une claudication (il faut vérifier la longueur des membres inférieurs) ;
- *La pointure des chaussures portées par les femmes peut orienter le diagnostic ⇔ petite taille, petits pieds et petites mains sont les signes d'un petit bassin :
 - Pointure de chaussure >38 : faible risque de bassin rétréci ;
 - Pointure de chaussure ≤35 : fort risque de bassin rétréci.

3-Palpation :

3.1-Hauteur utérine :

*Selon Leroy, les valeurs moyennes en centimètres de la hauteur utérine (cinquantième percentile de la population) sont :

- à 32 SA : 28 cm ;
- à 36 SA : 30-31 cm ;
- à 40 SA : 32-34 cm.

3.2-Périmètre abdominal :

*C'est le périmètre abdominal maternel mesuré au niveau de l'ombilic. Il augmente comme la hauteur utérine avec l'âge de la grossesse.

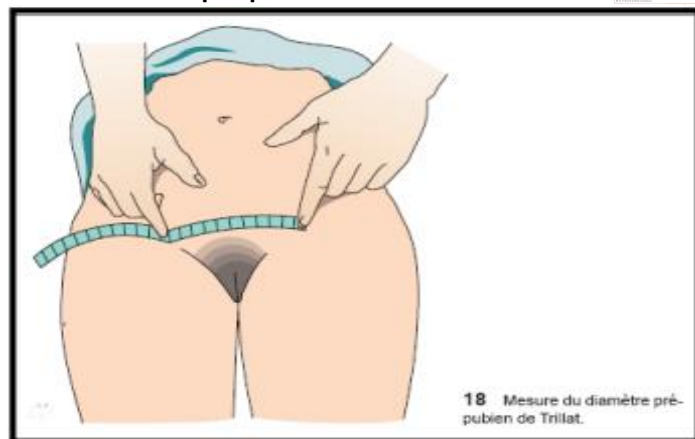
3.3-Palpation abdominale :

*Il permet d'apprécier la **présentation** du fœtus et la position de **son dos**. Il faut rechercher un débord suspubien ou une mobilité anormale de la tête foetale.

4-Pelvimétrie externe :

*Elle permet de mesurer :

- Le diamètre pré-pubien de Trillat :



- Le losange de Michaelis :

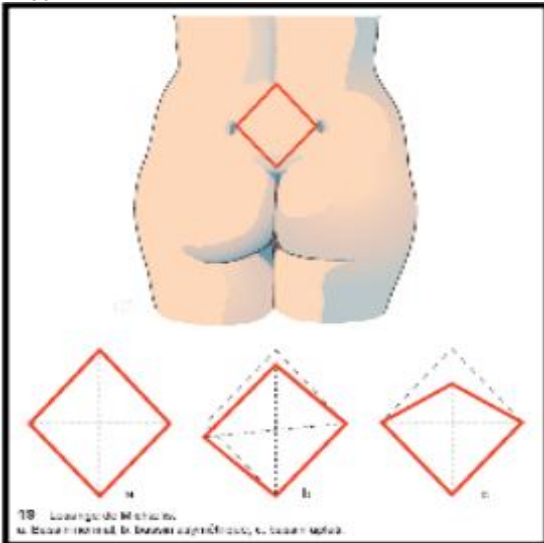
>La **fossette inférieure** correspond au sommet du pli interfessier ;

>Les **fossettes latérales** correspondent aux épine iliaques postérosupérieures

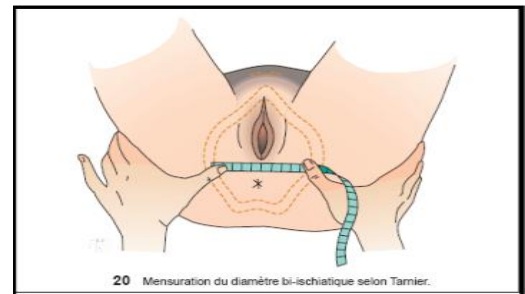
>La **fossette supérieure** correspond à l'apophyse épineuse de la cinquième vertèbre lombaire (L5).

→ La hauteur du losange de Michaelis est de 10 à 12 cm, et sa largeur est de 10 cm.

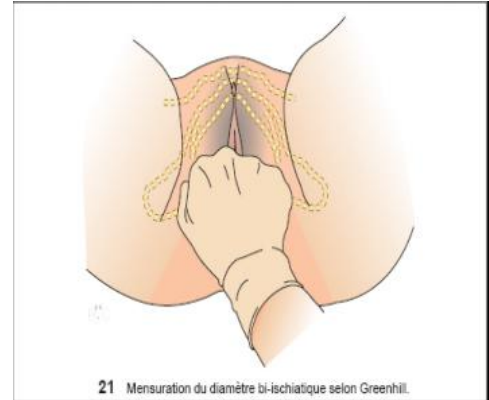
→ La forme de ce losange est variable selon le type d'anomalie.



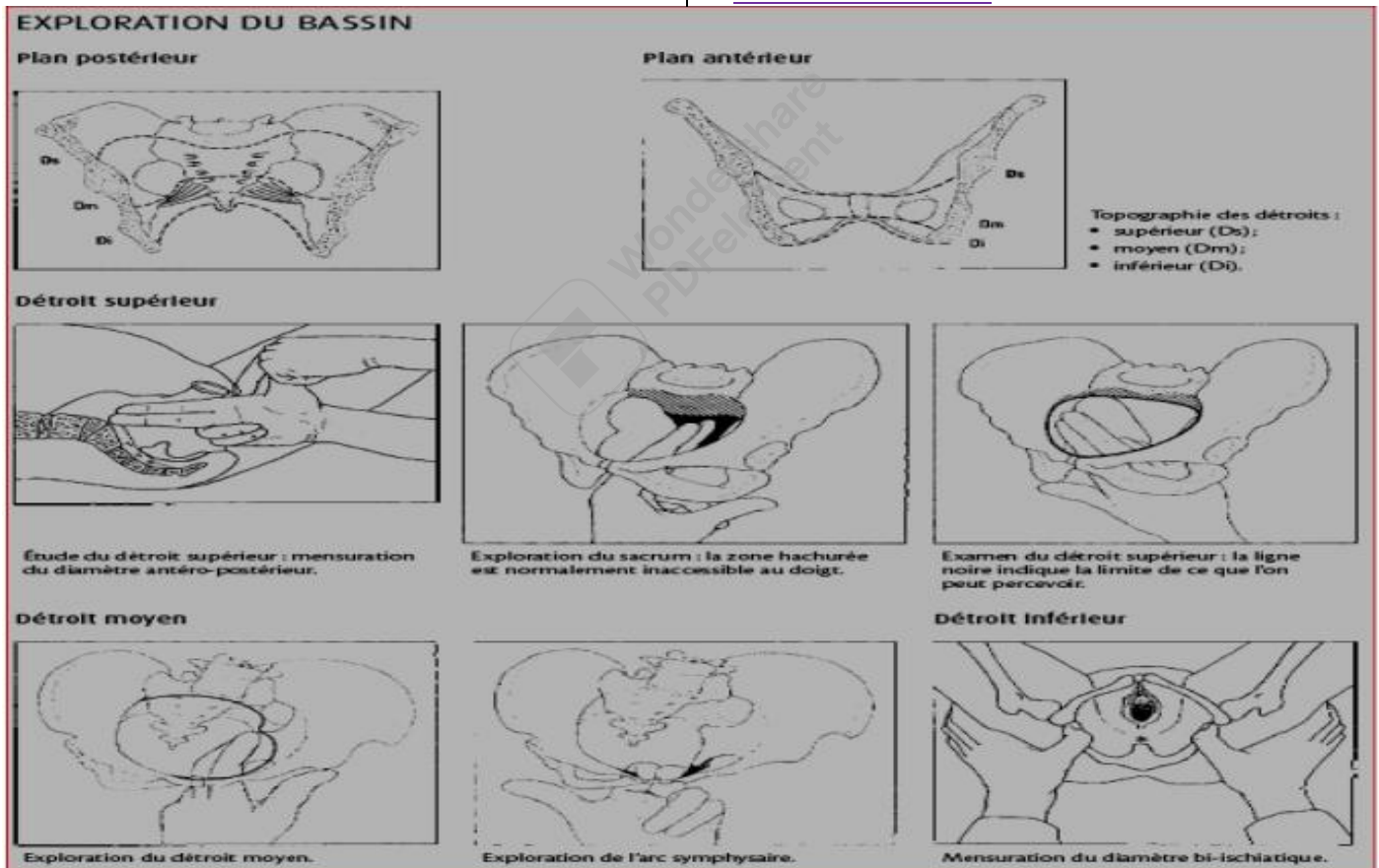
-La mesure des mensurations du diamètre bi-ischiatique selon Tamier



-La mesure des mensurations du diamètre bi-ischiatique selon Greenhill



5-Pelvimétrie interne :



*L'examen clinique du bassin est réalisé après la 37ème semaine d'aménorrhée. Il est un élément constitutif du pronostic obstétrical.
*La patiente doit être installée sur un plan dur, en position gynécologique, vessie et rectum vides.
*La main et l'avant-bras de l'examineur doivent rester dans le même axe que le bassin.
*L'exploration se fait toujours dans le même ordre et successivement :

-Exploration du DS :

• Etude du diamètre antéropostérieur ou PRP : Les doigts sont dirigés en direction du coccyx et de la dernière vertèbre sacrée. Puis ils remontent le long de la concavité sacrée en direction du promontoire.

• Exploration des lignes arquées : Puis les doigts suivent les lignes arquées.





-Exploration du DM :

• **Appréciation de la hauteur et de l'inclinaison de la symphyse pubienne**

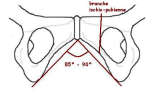
• **Recherche des épines sciatiques** : L'examen des parois latérales de l'excavation pelvienne permet d'apprécier la disposition des épines sciatiques. Il faut apprécier leur orientation, leur écartement et leur éventuelle saillie.

Attention à une saillie trop importante des épines sciatiques ou à une symphyse basse. (**bassin nordique**)



-Exploration du DI : Examen de l'ogive pubienne :

L'ogive pubienne est définie par les branches ischiopubiennes. Ces dernières sont situées dans un plan qui fait avec l'horizontale en station debout un angle de 40°. L'angle de l'ogive pubienne varie de 85 à 90°



IV-Examens para-cliniques :

1-Echographie en salle de travail :

* Pour confirmer les résultats de l'examen obstétrical, estimer la quantité de liquide amniotique et localiser l'insertion placentaire.

2-Radio ou scanopelvimétrie :

* Permettent d'obtenir les dimensions exactes des différents diamètres du bassin.

3-Tococardiographie :

* On apprécie les caractères des contractions utérines par la tocographie :

– durée ; – tonus de base ; – intensité ; – frq.

* Les anomalies de ces caractères sont recherchées (hypocinésie, hypercinésie, hypotonie, hypertonie).

* **Hypercinésie** : Augmentation trop importante du **rythme et de l'amplitude** des contractions utérines lors du travail de l'accouchement.

* **Hypertonie** : tonus exagéré du tonus musculaire

4-Cardiotocographie :

* Il s'agit d'un enregistrement simultané du rythme cardiaque foetal et des contractions utérines.

* Un tracé cardiotocographique normal pendant le travail se définit par :

– un RCF de base de 120 à 160 bpm,

- des oscillations d'amplitude comprise entre 5 et 25 bpm et de fréquence ≥ 4 cycles/min,
- une absence de ralentissement ;

V-1^{ère} phase : début du travail :

* La 1^{ère} partie du travail est dynamique : effacement et dilatation du col.

* Cette étape est marquée par l'association de contractions utérines fréquentes et régulières, et de modifications cervicales évolutives. Sous l'influence des contractions, le col s'efface (se raccourcit), puis se dilate jusqu'à 10 cm. La femme se présente à la maternité parce qu'elle ressent, depuis quelques heures, des contractions de fréquence et d'intensité croissantes.

1-Dc du travail :

* Il repose sur l'interrogatoire et le toucher vaginal.

* Les contractions du travail sont :

– Fréquentes : toutes les 5 à 10 minutes au début, puis toutes les 3 à 5 minutes,

– Régulières, et rapidement évolutives, de durée et d'intensité croissantes, devenant douloureuses.

* Le TV précise la **longueur** et la **dilatation** du col.

– Pendant la grossesse, le col est long d'au moins 2 cm et son orifice interne est fermé.

– Sous l'influence des contractions, il subit pendant le travail :

> un effacement (raccourcissement) allant jusqu'à la disparition du relief cervical,

> et une dilatation : col admettant un doigt, puis deux...etc

* Le diagnostic est évident si les modifications cervicales sont franches d'emblée. Ailleurs, une surveillance de quelques heures est nécessaire pour confirmer leur évolutivité.

Signes cliniques	Vrai travail	Faux travail
Contractions	Régulières	Irrégulières
Intervalle entre les contractions	↓ Diminue graduellement	Long
Intensité des contractions	↑↑ Augmente progressivement	Stable
Siège de la douleur	Dos et abdomen	Abdomino-pelvien
Effet de l'analgésie	Non arrêté par sédation	Souvent aboli
Modification du col	Effacement et dilatation	Pas de changement

QE!!

2-Surveillance du travail :

2.1-Clinique :

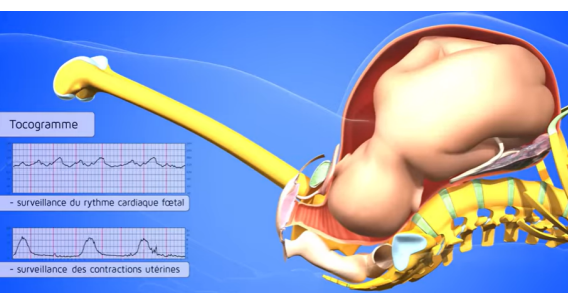
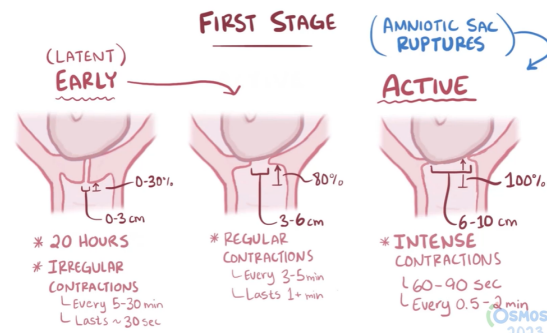
* Les modifications cervicales évoluent en deux temps :

DILATATION: 1 2 3 7 9 10
COMPLETE

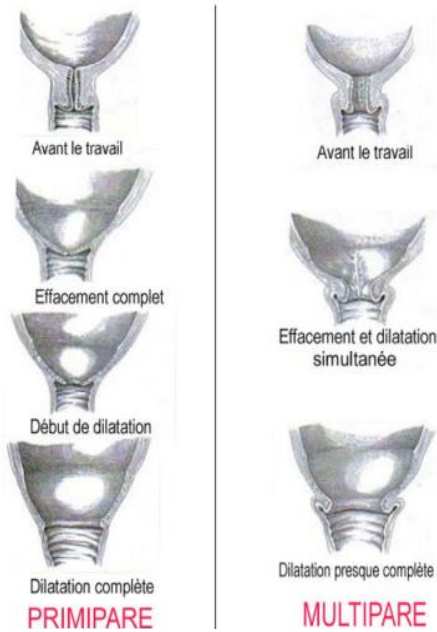
UNE PHASE DE DILATATION LENTE: LATENCE jusqu'à 5 cm, surtout marquée par l'effacement du col

UNE PHASE DE DILATATION RAPIDE : PHASE ACTIVE (> 1 cm / heure) jusqu'à dilatation complète (10cm).

Si les membranes ne se sont pas spontanément, il est habituel de les rompre artificiellement vers 4-5 cm. Cette mesure renforce l'intensité des contractions et favorise la dilatation cervicale.



Effacement et dilatation du col utérin chez la primipare et la multipare



*On peut s'aider du Bishop score to track l'évolution :

	0	1	2	3
Dilatation	fermé	1-2 cm	3-4 cm	≥ 5 cm
Effacement	0-30 %	40-60 %	60-70 %	≥ 80 %
Consistance	ferme	moyenne	molle	-
Position	postérieure	centrale	antérieure	-
Présentation	mobile	amorcée	fixée	engagée

2.2-Paraclinique :

*Il faut surveiller et consigner sur un document écrit, le **partogramme** :

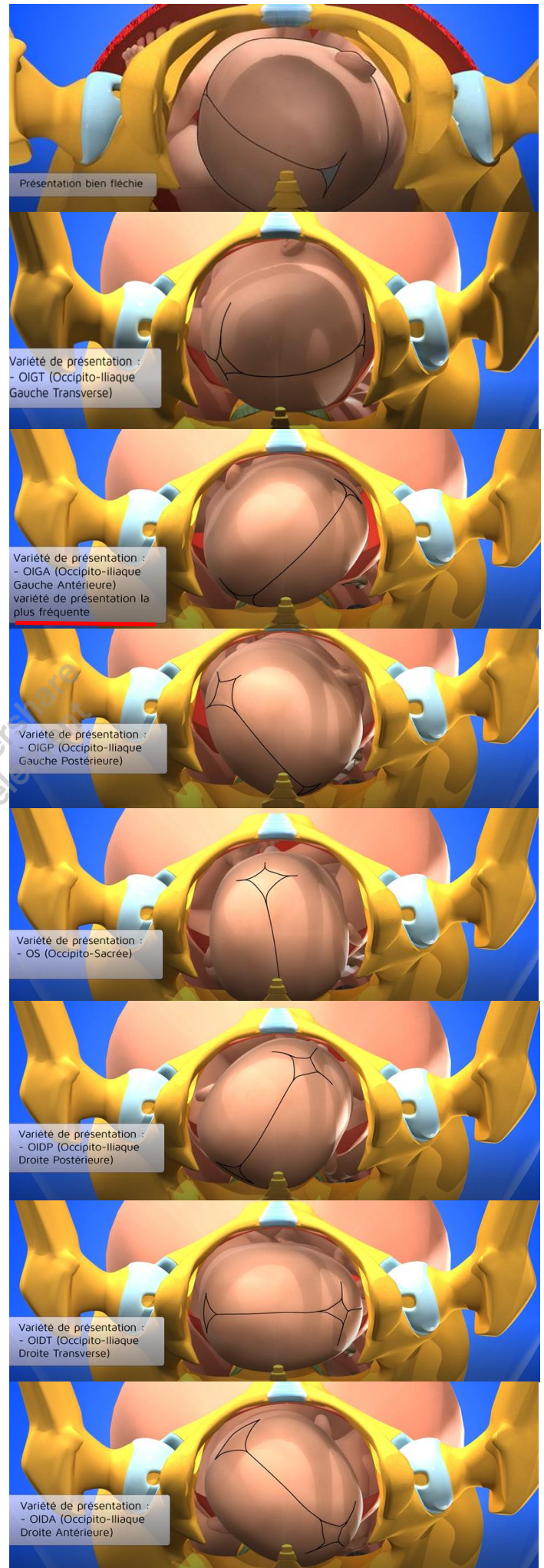
- **Le bien-être maternel** : pouls, tension, température
- **Le bien-être fœtal**, évalué par : l'enregistrement du RCF, la couleur du liquide amniotique, normalement claire → **Un liquide teinté est un signe d'alarme.**
- **La dynamique utérine et cervicale** : fréquence des contractions, qualité du relâchement entre les contractions, progression de la dilatation cervicale.

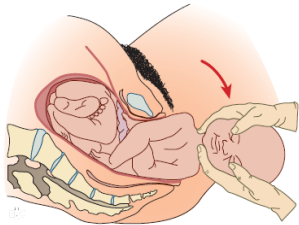
VI-2^{ème} phase : Fin de la dilatation → Naissance :

*La 2^{ème} partie du travail est mécanique.

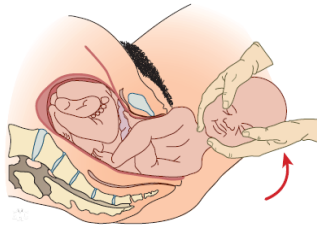
*L'étude de l'accouchement amène à décrire :

- La **présentation fœtale** : les variétés :

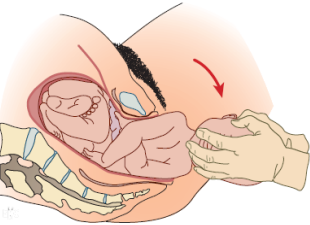




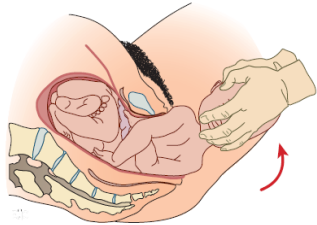
87 Dégagement de l'épaule antérieure (deuxième technique).



88 Dégagement de l'épaule postérieure (deuxième technique).



89 Dégagement de l'épaule antérieure (troisième technique).



90 Dégagement de l'épaule postérieure (troisième technique).

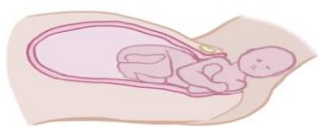
>Dégagement céphalique : passe par

-**Distension du périnée post** : l'hyperflexion de la tête accentue la descente, la région anococcygienne se distend, le coccyx est rétropulsé ;

-**Distension du périnée ant** : le noyau fibreux du périnée, abordé de front, est refoulé par la présentation qui s'en coiffe, le laminant et le distendant en tous sens. La distance anovulvaire triple ou quadruple, la vulve s'oriente directement « en avant »

-**Dégagement de la présentation** : elle s'effectue autour d'un point fixe sous-symphysaire, la vulve se laissant distendre progressivement. La partie sous-occipitale de la tête foetale se fixe sous la symphyse, ce qui constitue un point de rotation pour la déflexion de la tête. Lorsque la résistance périnéale est dominée, l'anus reste béant et le périnée postérieur bombe en permanence.

>Accouchement des épaules et du tronc



EXPULSION
ANTERIOR SHOULDER
↓
POSTERIOR SHOULDER
↓
REST of BODY (!)

>Accouchement du siège et des mb inf

→ Le dégagement du corps doit être facile : saisir l'enfant sous les aisselles, le dégager doucement en le tenant bien (attention au glissement) et le poser à la fin sur le ventre de sa mère.

VII-3^{ème} phase : Délivrance :

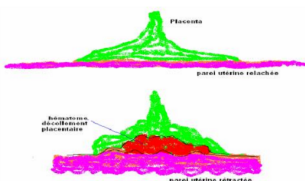
*C'est la 3^{ème} phase du travail, où le risque de complications graves est haut.

*Surveillance de la délivrance doit donc être rigoureuse et est exclusivement **clinique** : avant, pdt et après l'expulsion du délivre.

***L'hémorragie de la délivrance** étant une des principales causes de la mortalité maternelle.

*Elle se décompose en trois temps :

1-**Décollement du placenta** : entre les caduques compacte et spongieuse par constitution d'un Hématome Retro-Placentaire (HRP) physiologique ;



2-**Expulsion du placenta** : sous l'influence des contractions et de son propre poids → En pratique, elle est généralement aidée par l'accoucheur ;

3-**Hémostase** qui n'est possible que si l'utérus est vide :

>Assurée en premier lieu par la **rétraction utérine** : les fibres musculaires collabent les vaisseaux.

>L'hémostase biologique est plus tardive.

>Un retard à l'expulsion du placenta (**réten**tion **placentaire complète**), la persistance de débris (**réten**tion **partielle**) ou une défaillance du muscle utérin (**atonie utérine**) sont responsables **d'hémorragies de la délivrance**.

*Les différents modes de délivrance :

- Délivrance spontanée
- Délivrance naturelle
- Délivrance dirigée
- Délivrance artificielle



***La délivrance spontanée** : Le placenta est évacué spontanément avec l'aide de quelques efforts de poussée de la patiente en position verticale

***La délivrance naturelle** : Toute délivrance qui n'est pas spontanée, ou dirigée par des moyens médicamenteux est considérée comme une délivrance naturelle.

* **La délivrance dirigée** : la délivrance et l'hémostase se font sous l'influence des contractions et de la rétraction utérine. Leur qualité est fondamentale. Pour cette raison, beaucoup d'auteurs préconisent l'administration systématique d'ocytociques dès la sortie de l'enfant. C'est la délivrance dirigée.

***La délivrance artificielle** : Elle consiste en l'extraction manuelle du placenta hors de l'utérus.

*Après la délivrance :

-Examen du placenta et des membranes pour vérifier leur intégrité.

-Poursuivre la surveillance pendant 2 heures en salle de travail : pouls, Tension Artérielle, conscience, couleur, examen de la vulve (hgie), examen de l'utérus (palpation et inspection)

*Les complications de la délivrance :

- Atonie utérine
- Rétention placentaire complète
- Rétention placentaire incomplète
- Hémorragie de la délivrance
- Inversion utérine



VIII-Les suites de couches normales :

*Les suites de couches sont la période qui s'étend de l'accouchement jusqu'à la première menstruation normale, ou retour de couches.

1-Physiologie des suites de couches :

*2 jours après l'accouchement, on note un début de retour à l'état non gravide.

*La durée de normalisation est de 6 semaines.
*La lactation est un élément important en cette période.

*On note la possibilité de complications infectieuses, mammaires, thromboemboliques, et troubles (FOURTH STAGE)
physiques et/ou psychiques.

*En ce qui concerne l'aspect anatomique :

- ✓ Le corps utérin involue → état pré-gravide au bout de 2 mois
- ✓ A la 7^{ème} semaine du post-partum, la ½ interne se retrouve atrophiée et la ½ externe a retrouvé son aspect normal
- ✓ Le segment inférieur disparaît en 2 jours
- ✓ Le col se reconstitue en 1 semaine : il retrouve sa longueur de 1.5-2 cms, sa consistance by now est ferme
- ✓ Un ectropion est fréquemment visible et persiste pdt une durée de 6 mois – 1 an.
- ✓ L'endomètre évolue classiquement en 4 phases :

* ADAPTATION to BLOOD LOSS
* START of UTERINE INVOLUTION



- Une phase de régression pdt 5 jours suivant l'accouchement
- Une phase de cicatrisation du 6-25 jours indépendante de la stimulation hormonale
- Une phase de prolifération 25-45j sous l'effet de la stimulation oestrogénique: l'endomètre présente un aspect normale de la phase folliculaire
- Une phase de reprise éventuelle du cycle menstruel avec, chez la femme n'allaitant pas, une hémorragie de privation le 45^{em} jour

- ✓ Le vagin s'atrophie et ne reprend sa trophicité qu'à partir de la stimulation hormonale du 25^{ème} jour
- ✓ L'hymen est toujours dilaté
- ✓ La vulve reprend sa tonicité et perd son aspect congestif
- ✓ Le périnée retrouve sa tonicité en fct de la qualité de l'accouchement, d'une épisiotomie ou de la réparation correcte des déchirures

*Les glandes mammaires :

- ✓ On note une hypertrophie avec dvp des canaux galactophoriques (oestrogène) et des acini (progestérone)
- ✓ La montée laiteuse se produit 48h après l'accouchement : Après la délivrance, la chute brutale des taux d'oestrogènes et de progestérone stimule la sécrétion de prolactine.

*Pour l'ensemble de l'organisme le retour antérieur est progressif et il ne faudra prévoir aucun bilan morphologique avant 3 mois.

2-Surveillance des suites de couches :

*La surveillance du post-partum porte notamment sur :

- Les signes généraux : pouls, TA, température,
- L'involution du globe utérin : hauteur et consistance de l'utérus,
- Les lochies : abondance, aspect, odeur,
- Les membres inférieurs : recherche de signes de phlébite
- L'appareil urinaire : signes fonctionnels, aspect des urines.

* La prévention du risque thromboembolique repose sur :

- Lever précoce,
- Bas de contention si mauvais terrain veineux,
- Discuter un traitement anticoagulant préventif chez les femmes à risque.

*L'examen de sortie de la maternité doit prévoir la contraception du post-partum :

- En cas d'allaitement maternel, on préfère une contraception locale (spermicides, préservatifs) ou un microprogestatif
- En l'absence d'allaitement, on peut prescrire une pilule œstroprogestative en préférant une pilule faiblement dosée et en la débutant au plus tôt au 21^e jour du post-partum (risque thromboembolique).

IX-Quick recap :

